

До повторного прийому алерголога

Лада · 23.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Найбільше турбує зараз

Нинішнє погіршення астми почалося **в ту саму ніч після останнього прийому**. Дихати важко, ночами погано спить. Останніми днями складається враження, що вона або спить, або робить інгаляції через небулайзер. Іноді користується Вентоліном. Одного разу заснула під час інгаляції; я вимкнув прилад і розбудив її.

Я не розумію, чи достатньо того лікування, яке вона отримує, і чи правильно ми лікуємо астму між нападами. Хочу, щоб її оглянули, оцінили тяжкість нинішнього стану та дали зрозумілу схему на найближчі дні й надалі.

Окремо є виражена сонливість: повільніше думає та говорить, іноді трохи плутається і хитається під час ходьби, наче злегка п'яна. За останні два тижні подібне було щонайменше двічі, наступного дня могла бути цілком нормальною. Нещодавно знову викликала швидку через набряк і біль у горлі та утруднене дихання.

Інгалятори та інші ліки

Беродуал: повідомляла про 20-30 крапель за одну інгаляцію. **Пульмікорт:** один контейнер за інгаляцію; показувала препарат 0,5 мг/мл, 2 мл. Назвала по одному застосуванню кожного, але я не можу точно відтворити всі інгаляції за добу. **Вентолін** використовує іноді для швидкого полегшення.

Серетид Евохалер 25/125 мкг: 18.09 призначено по одному вдиху двічі на день. Користувалася ним 21.09; наскільки регулярно виконує цю схему, я не впевнений.

Медрол: початково призначили 16 мг зранку + 8 мг увечері на 14-20.09. Ще 22.09 вона казала, що приймає його за призначенням. Після нового виклику швидкої сказала, що їй порадили припинити через проблеми з животом. Потрібен чіткий подальший план. До цього протягом кількох тижнів періодично був дексаметазон, зокрема уколи під час невідкладної допомоги.

Гленцет Едванс приймає увечері щонайменше кілька днів; раніше приймала зранку і, за її словами, почувалася нормально. За останньою схемою також **Ніксар 20 мг зранку**. Гідазепам, тразодон та Димедрол зараз не приймає.

Алерголог: обстеження та питання

Лада · 23.09.2026

Що вже відомо

Астма та сезонна алергія тривають багато років, особливо важко з 2021 року. Лада розповідає про щорічні госпіталізації через астму на один або кілька тижнів, іноді з киснем. Останнього місяця також повторювалися напади з набряком язика/горла, плямами та болем у животі; неодноразово застосовували адреналін. Останній відомий мені ЕпіПен був уночі 16.09.

FeNO 18.09: 18 ppb, на тлі лікування стероїдами. ALEX 3: позитивні амброзія, полин, пилок жита та компонент селери Api g 7; загальний IgE 108 kU/L.

Удома 22.09 сатурація була **94%**; прилад на мені показував 94-96%, тому не впевнений у точності. Вночі була температура 38,2 °C, згодом 36,6 °C; приймала парацетамол. У записі швидкої 23.09: **SpO₂ 97%, тиск 120/80, пульс 67, температура 36 °C**.

Майже місяць їла приблизно **100 ккал/день**, зараз близько **800-1000 ккал/день**. Живіт часто болить після їжі та стероїдів. Раніше сильно набрякали обличчя, руки, ноги й живіт. Вага знову зросла: **22.09 - 65 кг; 23.09 - 68 кг**.

19.09: ТТГ 5,833 мкМО/мл, вільний Т4 0,54 нг/дл; гемоглобін 112 г/л. Сьогодні також плануємо ендокринолога й гастроентеролога.

Що хочу з'ясувати сьогодні

1. Наскільки тяжке нинішнє погіршення? Прошу оцінити дихання та сонливість і сказати, чи безпечно лікуватися вдома, чи потрібні сьогодні додаткові обстеження або стаціонар. Чи потрібні вимірювання пікової швидкості видиху, спірометрія з пробою, а при сонливості та поганому диханні - гази крові?

2. Якою має бути щоденна схема контролю астми? Чи достатній призначений Серетид для її стану; чи потрібна зміна препарату або дози? Прошу перевірити техніку інгаляції та потребу в спейсері.

3. Як саме користуватися засобами для полегшення? Потрібні конкретні дози, інтервали й межі застосування Вентоліну, Беродуалу та Пульмікورتу, їх поєднання з щоденним інгалятором і план дій, якщо полегшення коротке. Як відстежувати результат і коли повторний огляд?

4. Що робити з Медролом та рештою ліків? Прошу визначити тривалість і порядок завершення стероїдів з урахуванням попередніх курсів, болю в животі й набряків, а також перевірити, чи можуть ліки посилювати сонливість.

До прийому ендокринолога

Лада · 23.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Чому звертаємося

Лада має **дуже сильну втому й сонливість**. Останніми днями багато спить; іноді повільніше думає та говорить, трохи плутається, буває нестійкою при ходьбі, наче злегка п'яна. За останні два тижні подібне було щонайменше двічі; наступного дня могла бути цілком нормальною. Можливо, один із попередніх епізодів був після довгого сну і без нападу астми, але точно не пам'ятаю.

Паралельно дуже погано з астмою, повторюються набряки й алергічні реакції. Майже місяць їла приблизно **100 ккал/день**; зараз близько **800-1000 ккал/день**. Раніше набрякали обличчя, руки, ноги й живіт. **Вага: 21.09 - 63,5 кг; 22.09 - 65 кг; 23.09 - 68 кг**. Зріст 170 см.

Хочу зрозуміти, яку частину цього стану можуть пояснювати гормональні проблеми, чи можуть вони впливати на перебіг алергії й астми та що потрібно перевірити й лікувати зараз.

Щитоподібна залоза: результати в різні роки

16.04.2025, Сінево: ТТГ **3,14 мкМО/мл** (норма 0,27-4,2); вільний Т4 **0,765 нг/дл** (0,92-1,68). Антитіла до ТПО 11 МО/мл (<34), до тиреоглобуліну 15,8 МО/мл (<115).

24.03.2026, Сінево: ТТГ **3,41 мкМО/мл** (0,27-4,2). Вільного Т4 у цьому аналізі немає.

19.09.2026, ДІЛА: ТТГ **5,833 мкМО/мл** (0,400-4,850); вільний Т4 **0,54 нг/дл** (0,61-1,47); вільний Т3 2,64 пг/мл (2,30-4,20). Антитіла до ТПО <0,25 МО/мл (негативні <9), до тиреоглобуліну <0,9 МО/мл (негативні <4).

Попереднє лікування

Лада пригадує, що їй говорили про **автоімунну проблему щитоподібної залози**, але висновок не знайшли й у точності цього спогаду не впевнені. Призначали Еутирокс, йод і дієту «Протокол АІТ».

Еутирокс приймала навесні 2025 року приблизно два місяці, потім припинила, бо не відчувала покращення, і більше до цього не поверталася. Дозу не пам'ятає. Не впевнені, чи аналіз 16.04.2025 був до лікування або вже під час нього.

Ендокринолог: ліки та питання

Лада · 23.09.2026

Ліки й інші результати, які можуть бути важливими

Протягом останніх тижнів неодноразово приймала **дексаметазон**, також отримувала його під час невідкладної допомоги. З 14.09 призначали **Медрол 16 мг зранку + 8 мг увечері до 20.09**; ще 22.09 казала, що приймає за призначенням. Згодом швидка порадила припинити через проблеми з животом. Потрібен зрозумілий план подальшого прийому або завершення.

Для астми призначений **Серетид Евохалер 25/125**, використовує **Беродуал**, останніми днями також **Пульмікорт**, іноді **Вентолін**. **Гленцет Едванс** приймає ввечері щонайменше кілька днів; за останньою схемою також Ніксар 20 мг зранку. Зараз не приймає гідазепам, тразодон чи Димедрол.

19.09: гемоглобін 112 г/л, MCV 78,9 фл; натрій 140, калій 4,06, магній 0,76, фосфор 1,43, кальцій загальний 2,31, глюкоза 5,6 ммоль/л; креатинін 66 мкмоль/л, альбумін 36 г/л.

14.09: феритин 31,5 нг/мл, насичення трансферину залізом 9,05%. **24.03.2026:** вітамін D 15,8 нг/мл, глюкоза 5 ммоль/л. Ці результати отримані в різні дні, не під час кожного епізоду сонливості.

Що хочу з'ясувати сьогодні

1. Як пояснити результати щитоподібної залози? Вільний T4 був зниженим і у 2025 році при нормальному ТТГ, і зараз при підвищеному ТТГ. Чи потрібні повторні ТТГ та вільний T4, коли їх краще здати з урахуванням нинішнього стану, харчування й стероїдів? Чи потрібні інші гормональні обстеження, а не лише ТТГ?

2. Чи потрібне лікування вже зараз? Якщо потрібен Еутирокс або інше лікування, прошу вказати конкретну схему, час прийому щодо їжі й інших ліків, строк контролю аналізів та очікуваний час покращення. Чи є підстави вважати проблему автоімунною?

3. Як оцінити сонливість, слабкість і вплив стероїдів? Прошу оцінити, чи можуть це пояснювати гормони, чи потрібна сьогодні інша перевірка. Чи потрібно перевіряти роботу наднирників після повторних курсів; якщо так, коли й як це зробити, щоб прийом стероїдів не спотворив результат? Як безпечно завершити їх з урахуванням лікування астми?

4. Чи пов'язані ці зміни з набряками, алергією та астмою? Хочу зрозуміти, що може покращитися від лікування гормональної проблеми, що потребує окремої оцінки та які додаткові аналізи справді потрібні з огляду на недостатнє харчування, гемоглобін і залізо.

До повторного прийому гастроентеролога

Лада · 23.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Що найбільше турбує

Скарги залишаються тими самими, що на попередньому прийомі: **частий біль у животі, особливо після їжі та після стероїдів**. Їсти стала більше, але досі дуже мало. Хочу, щоб її оглянули й пояснили, чи безпечно продовжувати лікування та відновлення харчування вдома, чи потрібні обстеження або стаціонар.

22.09 приблизно через 15 хвилин після Медролу почався біль у животі силою близько **5-6 із 10**. Вона їла приблизно за годину до таблетки. Цей біль відрізнявся від попереднього сильного болю під час нападів. Загалом після тяжких нападів живіт іноді болить кілька днів.

Харчування та вага

За моєю нинішньою оцінкою, майже місяць вона отримувала близько **100 ккал/день**. Тепер близько **800-900, можливо 1000 ккал/день**. Їсти заважають біль, слабкий апетит і страх реакцій. Останнім часом могла їсти крекери та кисломолочний сир, але раціон залишається дуже обмеженим.

Каші, рис і макарони давно уникає через погане самопочуття після них та попередні поради щодо кишківника. Розповідала також про червоні плями після деяких фруктів та овочів, зокрема моркви й помідорів. Точний зв'язок усіх симптомів з їжею нам незрозумілий.

Лікарі швидкої після огляду й розмови з нею сказали, що потрібно **їсти більше овочів, щоб посилити перистальтику**, і що при нинішньому харчуванні може знову бути непрохідність. Нам потрібні конкретні рекомендації: які продукти, у якому вигляді й кількості підходять саме їй.

Зріст 170 см. Раніше були виражені набряки обличчя, рук, ніг і живота. **Вага: 19.09 - 66,6 кг; 20.09 - 64,1 кг; 21.09 - 63,5 кг; 22.09 - 65 кг; сьогодні, 23.09 - 68 кг.**

Важливе з минулого

У березні 2026 року була госпіталізація через кишкову непрохідність, обійшлося без операції. У 2024-2026 роках перенесла кілька операцій через кісти яєчників; навесні 2026 були кровотечі, спайки з кишківником, маткою та сечовим міхуром і часткове видалення правого яєчника.

З дитинства пригадує виразку, гастрит або гастродуоденіт, точної назви не пам'ятає. Апетит погіршився ще приблизно минулої зими. Раніше також турбували нудота, здуття, чергування діареї та відсутності випорожнень.

Гастроентеролог: лікування та питання

Лада · 23.09.2026

Після попереднього прийому

14.09 призначали **Омез 20 мг зранку, Квамател 40 мг перед сном та Домрид SR 30 мг**. У рекомендаціях алерголога від 18.09 Квамател уже зазначений **по 20 мг двічі на день**. Прошу узгодити одну схему для живота й оцінити її ефект.

Медрол початково призначали **16 мг зранку + 8 мг увечері на 14-20.09**; ще 22.09 вона казала, що приймає його за призначенням. Потім швидко порадила припинити через проблеми з животом. До цього кілька тижнів періодично приймала дексаметазон та отримувала його під час невідкладної допомоги. **17.09 отримала Дексалгін і приймала німесулід; 18.09 також повідомляла про Німесил.**

Зараз важко з астмою, використовує небулайзер та іноді Вентолін, багато спить. Бувають сповільнене мислення й мовлення та нестійкість при ходьбі. Сьогодні також плануємо алерголога й ендокринолога.

Аналізи, які вже маємо

19.09: гемоглобін 112 г/л, MCV 78,9 фл; калій 4,06, магній 0,76, натрій 140, фосфор 1,43, кальцій загальний 2,31, глюкоза 5,6 ммоль/л. Креатинін 66 мкмоль/л, альбумін 36 г/л; АЛТ 17, АСТ 18, ГГТ 11, лужна фосфатаза 39 Од/л, білірубін 7,7 мкмоль/л.

14.09: феритин 31,5 нг/мл, насичення трансферину залізом 9,05%. **19.09:** ТТГ 5,833 мкМО/мл, вільний Т4 0,54 нг/дл.

Що хочу вирішити сьогодні

1. Причина болю й безпека лікування вдома. Прошу оглянути живіт та оцінити біль після їжі й ліків з урахуванням попередньої непрохідності та операцій. Чи потрібні сьогодні аналізи, обстеження живота, ендоскопія або стаціонар? Як полегшити біль, щоб вона могла їсти?

2. Конкретний план харчування. Що їй можна їсти зараз, якими порціями й як збільшувати кількість після майже місяця дуже малого харчування? Які овочі та спосіб приготування підходять з огляду на непрохідність і реакції на їжу? Чи потрібне спеціальне лікувальне харчування?

3. Контроль під час збільшення їжі. Чи потрібно зараз повторити фосфор, калій, магній, глюкозу та інші показники; як часто їх контролювати? Чи потрібні вітаміни, зокрема B1, або інша підтримка? Як оцінити швидку зміну ваги й набряки?

4. Подальше лікування й обстеження. Прошу визначити схему для шлунка з урахуванням лікування астми та болю після стероїдів. На минулому прийомі призначали аналізи калу на Н. рylogi, приховану кров і кальпротектин: що зараз пріоритетне та як підготуватися з урахуванням ліків? Чи потрібне лікування нестачі заліза, яке вона зможе переносити?